

アクティブラーニング

名古屋市立大学産科婦人科学教室 西川隆太郎

今日は

- みんなで臨床問題を解きます
- 何人か当てて考え方を聞きます

皆で答えを導き出せる考え方を学びましょう

医学科授業アンケート2026年 生殖
機能（婦人科）



問題

とある日・・・

65歳女性が産婦人科外来を受診されました。

主訴は

3か月前からの“不正”性器出血
です。

この時点で思いつく疾患を挙げましょう

問題

とある日・・・

65歳女性が産婦人科外来を受診されました。

主訴は

3か月前からの“不正”性器出血
です。

この時点で思いつく疾患を挙げましょう

3分以内に 何個でもいいです

不正性器出血の鑑別

1. 月経異常 機能性出血(ホルモンバランスの乱れ)
2. 妊娠(切迫流産 絨毛性疾患 切迫早産)
3. 悪性腫瘍
 1. 子宮頸癌 子宮体癌 膣癌 外陰癌
 2. 卵巣境界悪性腫瘍(ホルモン産生) ; 顆粒膜細胞腫
4. 良性腫瘍
 1. 子宮筋腫(特に粘膜下筋腫の筋腫分娩)
 2. 頸管ポリープ 内膜ポリープ
5. 炎症 膣炎 萎縮性膣炎、クラミジア 淋菌など
6. 婦人科でない疾患
 1. 痔核
 2. 尿路系疾患
 3. 出血性疾患
 4. 抗凝固薬内服

不正性器出血の鑑別

1. 月経異常 機能性出血(ホルモンバランスの乱れ)
2. 妊娠(切迫流産 絨毛性疾患 切迫早産)
3. 悪性腫瘍
 1. 子宮頸癌 子宮体癌 膣癌 外陰癌
 2. 卵巣境界悪性腫瘍(ホルモン産生) ; 顆粒膜細胞腫
4. 良性腫瘍
 1. 子宮筋腫(特に粘膜下筋腫の筋腫分娩)
 2. 頸管ポリープ 内膜ポリープ
5. 炎症 膣炎 萎縮性膣炎、クラミジア 淋菌など
6. 婦人科でない疾患
 1. 痔核
 2. 尿路系疾患
 3. 出血性疾患
 4. 抗凝固薬内服

月経周期 閉経有無
妊娠可能性有無
は確認すべき

不正性器出血の鑑別

1. 月経異常 機能性出血(ホルモンバランスの乱れ)

2. 妊娠(切迫流産 絨毛性疾患 切迫早産)

3. 悪性腫瘍

1. 子宮頸癌 子宮体癌 膣癌 外陰癌

2. 卵巣境界悪性腫瘍(ホルモン産生) ; 顆粒膜細胞腫

4. 良性腫瘍

1. 子宮筋腫(特に粘膜下筋腫の筋腫分娩)

2. 頸管ポリープ 内膜ポリープ

5. 炎症 膣炎 萎縮性膣炎、クラミジア 淋菌など

6. 婦人科でない疾患

1. 痔核

2. 尿路系疾患

3. 出血性疾患

4. 抗凝固薬内服

月経周期 閉経有無
妊娠可能性有無
は確認すべき

悪性腫瘍家族歴(遺伝要因)
婦人科検診の結果
随伴症状(腰痛 帯下 等)

不正性器出血の鑑別

1. 月経異常 機能性出血(ホルモンバランスの乱れ)

2. 妊娠(切迫流産 絨毛性疾患 切迫早産)

3. 悪性腫瘍

1. 子宮頸癌 子宮体癌 膣癌 外陰癌

2. 卵巣境界悪性腫瘍(ホルモン産生) ; 顆粒膜細胞腫

4. 良性腫瘍

1. 子宮筋腫(特に粘膜下筋腫の筋腫分娩)

2. 頸管ポリープ 内膜ポリープ

5. 炎症 膣炎 萎縮性膣炎、クラミジア 淋菌など

6. 婦人科でない疾患

1. 痔核

2. 尿路系疾患

3. 出血性疾患

4. 抗凝固薬内服

月経周期 閉経有無
妊娠可能性有無
は確認すべき

悪性腫瘍家族歴(遺伝要因)
婦人科検診の結果
随伴症状(腰痛 帯下 等)

ホルモン産生腫瘍による症状
肌つやが良い 月経様出血など

不正性器出血の鑑別

1. 月経異常 機能性出血(ホルモンバランスの乱れ)

2. 妊娠(切迫流産 絨毛性疾患 切迫早産)

月経周期 閉経有無
妊娠可能性有無
は確認すべき

3. 悪性腫瘍

1. 子宮頸癌 子宮体癌 膣癌 外陰癌

2. 卵巣境界悪性腫瘍(ホルモン産生) ; 顆粒膜細胞腫

悪性腫瘍家族歴(遺伝要因)
婦人科検診の結果
随伴症状(腰痛 帯下 等)

4. 良性腫瘍

1. 子宮筋腫(特に粘膜下筋腫の筋腫分娩)

2. 頸管ポリープ 内膜ポリープ

ホルモン産生腫瘍による症状
肌つやが良い 月経様出血など

5. 炎症 膣炎 萎縮性膣炎、クラミジア 淋菌など

6. 婦人科でない疾患

1. 痔核

2. 尿路系疾患

3. 出血性疾患

4. 抗凝固薬内服

かゆみ 痛みの有無
性交歴
職業(CSWなど)

不正性器出血の鑑別

1. 月経異常 機能性出血(ホルモンバランスの乱れ)
2. 妊娠(切迫流産 絨毛性疾患 切迫早産)
3. 悪性腫瘍
 1. 子宮頸癌 子宮体癌 膣癌 外陰癌
 2. 卵巣境界悪性腫瘍(ホルモン産生) ; 顆粒膜細胞腫
4. 良性腫瘍
 1. 子宮筋腫(特に粘膜下筋腫の筋腫分娩)
 2. 頸管ポリープ 内膜ポリープ
5. 炎症 膣炎 萎縮性膣炎、クラミジア 淋菌など
6. 婦人科でない疾患
 1. 痔核
 2. 尿路系疾患
 3. 出血性疾患
 4. 抗凝固薬内服

悪性腫瘍家族歴(遺伝要因)
婦人科検診の結果
随伴症状(腰痛 帯下 等)

不正性器出血の鑑別

1. 月経異常 機能性出血(ホルモンバランスの乱れ)
2. 妊娠(切迫流産 絨毛性疾患 切迫早産)
3. 悪性腫瘍
 1. 子宮頸癌 子宮体癌 膣癌 外陰癌
 2. 卵巣境界悪性腫瘍(ホルモン産生) ; 顆粒膜細胞腫
4. 良性腫瘍
 1. 子宮筋腫(特に粘膜下筋腫の筋腫分娩)
 2. 頸管ポリープ 内膜ポリープ
5. 炎症 膣炎 萎縮性膣炎、クラミジア 淋菌など
6. 婦人科でない疾患
 1. 痔核
 2. 尿路系疾患
 3. 出血性疾患
 4. 抗凝固薬内服

悪性腫瘍家族歴(遺伝要因)
婦人科検診の結果
随伴症状(腰痛 帯下 等)

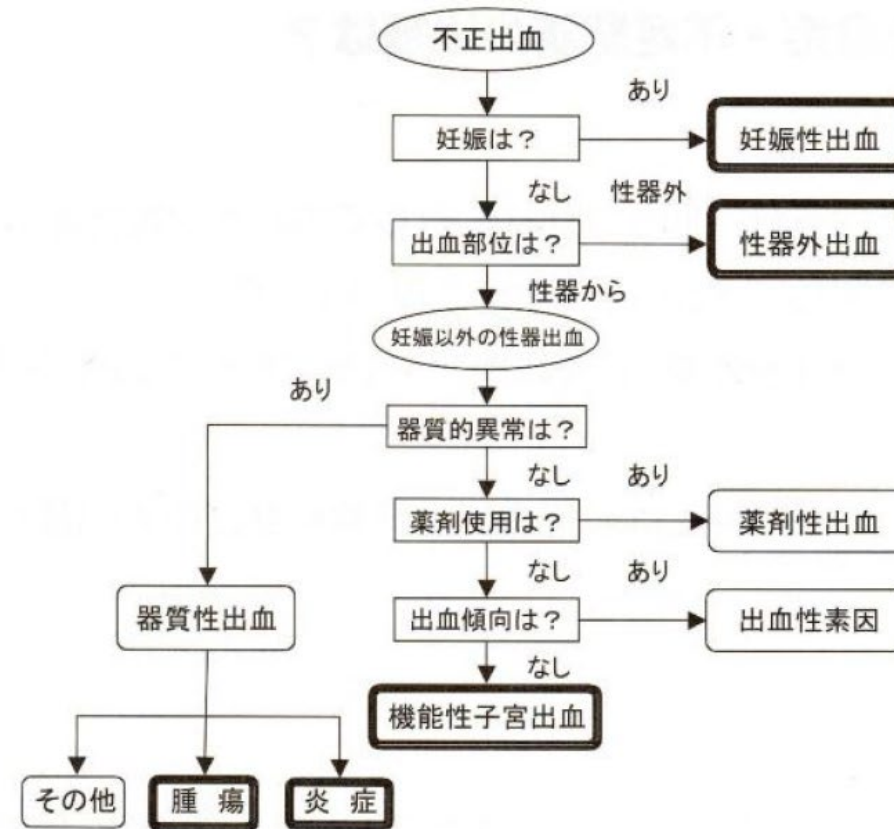
リスク要因の有無

- ・ 妊娠歴
- ・ 初経 閉経時期
- ・ ホルモンに影響ある内服薬
 - ・ 肥満
- ・ 不妊治療歴
- ・ 性交歴

不正性器出血の鑑別

1. 月経異常 機能性出血(ホルモンバランスの乱れ)
2. 妊娠(切迫流産 絨毛性疾患 切迫早産)
3. 悪性腫瘍
 1. 子宮頸癌 子宮体癌 膣癌 外陰癌
 2. 卵巣境界悪性腫瘍(ホルモン産生) ; 顆粒膜細胞腫
4. 良性腫瘍
 1. 子宮筋腫(特に粘膜下筋腫の筋腫分娩)
 2. 頸管ポリープ 内膜ポリープ
5. 炎症 膣炎 萎縮性膣炎、クラミジア 淋菌など
6. 婦人科でない疾患
 1. 痔核
 2. 尿路系疾患
 3. 出血性疾患
 4. 抗凝固薬内服

不正性器出血の鑑別



不正性器出血の鑑別 問診事項

- 妊娠有無
- 分娩歴
- 身長体重
- 既往歴 手術歴
- 内服薬
- 癌の家族歴 発症年齢
- 出血のタイミング 量 性状
- 随伴症状有無 帯下 疼痛 など
- これまでの検診の結果

参考問題

47歳女性。1か月前からの不正性器出血と腰痛を主訴に来院した。月経周期は32日型。内診で子宮頸部から右側骨盤壁に連続する硬結を触知する。血液所見：赤血球385万、Hb11.0g/dL、Ht33%、白血球9500、血小板45万。血液生化学所見：総蛋白6.8g/dL、アルブミン3.5g/dL、AST30U/L、ALT22U/L、尿素窒素28mg/dL、クレアチニン0.7mg/dL。腔鏡診で子宮腔部に径4cmのカリフラワー状で易出血性の腫瘤を認めた。生検で扁平上皮癌と診断された。遠隔転移を認めない。

適切な治療はどれか。

- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| a.手術 | b.放射線療法 | c.抗癌化学療法 |
| d.分子標的薬投与 | e.化学放射線療法 | |

参考問題

47歳女性。1か月前からの不正性器出血と腰痛を主訴に来院した。月経周期は32日型。内診で子宮頸部から右側骨盤壁に連続する硬結を触知する。血液所見：赤血球385万、Hb11.0g/dL、Ht33%、白血球9500、血小板45万。血液生化学所見：総蛋白6.8g/dL、アルブミン3.5g/dL、AST30U/L、ALT22U/L、尿素窒素28mg/dL、クレアチニン0.7mg/dL。腔鏡診で子宮腔部に径4cmのカリフラワー状で易出血性の腫瘤を認めた。生検で扁平上皮癌と診断された。遠隔転移を認めない。

適切な治療はどれか。

- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| a.手術 | b.放射線療法 | c.抗癌化学療法 |
| d.分子標的薬投与 | e.化学放射線療法 | |

体癌も頸癌もある
閉経していないから月経異常？
月経？
多分妊娠はないと思うけど・・・

参考問題

47歳女性。1か月前からの不正性器出血と腰痛を主訴に来院した。月経周期は32日型。内診で子宮頸部から右側骨盤壁に連続する硬結を触知する。血液所見：赤血球385万、Hb11.0g/dL、Ht33%、白血球9500、血小板45万。血液生化学所見：総蛋白6.8g/dL、アルブミン3.5g/dL、AST30U/L、ALT22U/L、尿素窒素28mg/dL、クレアチニン0.7mg/dL。腔鏡診で子宮腔部に径4cmのカリフラワー状で易出血性の腫瘤を認めた。生検で扁平上皮癌と診断された。遠隔転移を認めない。

適切な治療はどれか。

- a.手術
- b.放射線療法
- c.抗癌化学療法
- d.分子標的薬投与
- e.化学放射線療法

体癌も頸癌もある
閉経していないから月経異常？
月経？
多分妊娠はないと思うけど・・・

参考問

悪そう！ でも腺筋症とか筋腫もあるか・・・
ていうか骨盤壁に達する腫瘍って
いったら頸癌のステージングだね！

47歳女性。1か月前からの不正性器出血と腰痛を主訴に来院した。月経周期は32日型。内診で子宮頸部から右側骨盤壁に連続する硬結を触知する。血液所見：赤血球385万、Hb11.0g/dL、Ht33%、白血球9500、血小板45万。血液生化学所見：総蛋白6.8g/dL、アルブミン3.5g/dL、AST30U/L、ALT22U/L、尿素窒素28mg/dL、クレアチニン0.7mg/dL。腔鏡診で子宮腔部に径4cmのカリフラワー状で易出血性の腫瘍を認めた。生検で扁平上皮癌と診断された。遠隔転移を認めない。

適切な治療はどれか。

- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| a.手術 | b.放射線療法 | c.抗癌化学療法 |
| d.分子標的薬投与 | e.化学放射線療法 | |

体癌も頸癌もある
閉経していないから月経異常？
月経？
多分妊娠はないと思うけど・・・

参考問

悪そう！ でも腺筋症とか筋腫もあるか・・・
ていうか骨盤壁に達する腫瘍って
いったら頸癌のステージングだね！

47歳女性。1か月前からの不正性器出血と腰痛を主訴に来院した。月経周期は32日型。内診で子宮頸部から右側骨盤壁に連続する硬結を触知する。血液所見：赤血球385万、Hb11.0g/dL、Ht33%、白血球9500、血小板45万。血液生化学所見：総蛋白6.8g/dL、アルブミン3.5g/dL、AST30U/L、ALT22U/L、尿素窒素28mg/dL、クレアチニン0.7mg/dL。腔鏡診で子宮腔部に径4cmのカリフラワー状で易出血性の腫瘍を認めた。生検で扁平上皮癌と診断された。遠隔転移を認めない。

適切な治療はどれか。

a. 手術療法

b. 放射線療法

c. 抗癌化学療法

扁平上皮癌やんか 頸癌で多い組織型だから頸癌で決まりだね

d. 化学療法

体癌も頸癌もある
閉経していないから月経異常？
月経？
多分妊娠はないと思うけど・・・

参考問

悪そう！ でも腺筋症とか筋腫もあるか・・・
ていうか骨盤壁に達する腫瘍って
いったら頸癌のステージングだね！

47歳女性。1か月前からの不正性器出血と腰痛を主訴に来院した。月経周期は32日型。内診で子宮頸部から右側骨盤壁に連続する硬結を触知する。血液所見：赤血球385万、Hb11.0g/dL、Ht33%、白血球9500、血小板45万。血液生化学所見：総蛋白6.8g/dL、アルブミン3.5g/dL、AST30U/L、ALT22U/L、尿素窒素28mg/dL、クレアチニン0.7mg/dL。腔鏡診で子宮腔部に径4cmのカリフラワー状で易出血性の腫瘍を認めた。生検で扁平上皮癌と診断された。遠隔転移を認めない。

適切な治療はどれか。

a. 手術療法

b. 放射線療法

c. 抗癌化学療法

扁平上皮癌やんか 頸癌で多い組織型だから頸癌で決まりだね

4cmで遠隔転移ないならⅠb期？あでも骨盤壁に達しているからⅢB期か

体癌も頸癌もある
閉経してないから月経異常？
月経？
多分妊娠はないと思うけど・・・

参考問

悪そう！ でも腺筋症とか筋腫もあるか・・・
ていうか骨盤壁に達する腫瘍って
いったら頸癌のステージングだね！

47歳女性。1か月前からの不正性器出血と腰痛を主訴に来院した。月経周期は32日型。内診で子宮頸部には全周性外生性腫瘍が認められ、子宮頸管より約2cm深さまで達する。

子宮頸癌ⅢB期

適切な治療はどれか。

a. 手術

b. 放射線療法

c. 抗癌化学療法

扁平上皮癌やんか 頸癌で多い組織型だから頸癌で決まりだね

4cmで遠隔転移ないならⅠb期？あでも骨盤壁に達しているからⅢB期か

参考問題

47歳女性。1か月前からの不正性器出血と腰痛を主訴に来院した。月経周期は32日型。内診で子宮頸部から右側骨盤壁に連続する硬結を触知する。血液所見：赤血球385万、Hb11.0g/dL、Ht33%、白血球9500、血小板45万。血液生化学所見：総蛋白6.8g/dL、アルブミン3.5g/dL、AST30U/L、ALT22U/L、尿素窒素28mg/dL、クレアチニン0.7mg/dL。腔鏡診で子宮腔部に径4cmのカリフラワー状で易出血性の腫瘤を認めた。生検で扁平上皮癌と診断された。遠隔転移を認めない。

適切な治療はどれか。

a.手術

b.放射線療法

c.抗癌化学療法

d.分子標的薬投与

e.化学放射線療法

参考問題

30歳女性。未経妊。月経不順と過多月経を主訴に来院した。内診では子宮は正常大で、付属器には腫瘤を触知しない。経膈超音波検査では、子宮内膜の厚さは24mmで、卵巣の被膜下には多数の小嚢胞を認め、軽度に腫大している。

検査として適切なのはどれか。2つ選べ。

- a.腹腔鏡検査 b.子宮鏡検査 c.子宮卵管造影
- d.子宮頸部細胞診 e.子宮内膜組織診

参考問題

30歳女性。未経妊。月経不順と過多月経を主訴に来院した。内診では子宮は正常大で、付属器には腫瘤を触知しない。経膈超音波検査では、子宮内膜の厚さは24mmで、卵巣の被膜下には多数の小嚢胞を認め、軽度に腫大している。

検査として適切なのはどれか。2つ選べ。

- a.腹腔鏡検査 b.子宮鏡検査 c.子宮卵管造影
- d.子宮頸部細胞診 e.子宮内膜組織診

無排卵周期で未経妊
→若いけど体癌リスクあるね

参考問題

30歳女性。未経妊。月経不順と過多月経を主訴に来院した。内診では子宮は正常大で、付属器には腫瘤を触知しない。経膈超音波検査では、子宮内膜の厚さは24mmで、卵巣の被膜下には多数の小嚢胞を認め、軽度に腫大している。

検査として適切なのはどれか。2つ選べ。

- a.腹腔鏡検査 b.子宮鏡検査 c.子宮卵管造影
- d.子宮頸部細胞診 e.子宮内膜組織診

無排卵周期で未妊妊
→若いけど体癌リスクあるね

参考問題

30歳女性。未妊妊。月経不順と過多月経を主訴に来院した。内診では子宮は正常大で、付属器には腫瘤を触知しない。経膈超音波検査では、子宮内膜の厚さは24mmで、卵巣の被膜下には多数の小嚢胞を認め、軽度に腫大している。

検査として適切なのはどれか。2つ選べ。

- a.腹腔鏡検査
- b.子宮鏡検査
- c.子宮卵管造影
- d.子宮頸部細胞診
- e.子宮内膜組織診

大きな筋腫、腺筋症では
どうやらないようだ
内膜ポリープや、筋腫なら粘膜下
筋腫？

無排卵周期で未経妊
→若いけど体癌リスクあるね

参考問題

30歳女性。未経妊。月経不順と過多月経を主訴に来院した。内診では子宮は正常大で、付属器には腫瘤を触知しない。経膈超音波検査では、子宮内膜の厚さは24mmで、卵巣の被膜下には多数の小嚢胞を認め、軽度に腫大している。

検査として適切なのはどれか。2つ選べ。

- a. 腹腔鏡検査
- b. 子宮鏡検査
- c. 子宮卵巣超音波検査
- d. 子宮頸部細胞診
- e. 子宮内膜生検

内膜肥厚は閉経前15mm以上
※閉経後は5mm以上

内膜分厚い！

大きな筋腫、腺筋症では
どうやらないようだ
内膜ポリープや、筋腫なら粘膜下
筋腫？

参考問題

無排卵周期で未経妊
→若いけど体癌リスクあるね

30歳女性。未経妊。月経不順と過多月経を主訴に来院した。内診では子宮は正常大で、付属器には腫瘤を触知しない。経膈超音波検査では、子宮内膜の厚さは24mmで、卵巣の被膜下には多数の小嚢胞を認め、軽度に腫大している。

検査として適切なものを2つ選べ。

a.腹腔鏡検査

b.子宮鏡検査

c.子宮卵巣超音波検査

多数の小嚢胞
→PCOS（多嚢胞性卵巣症候群）

内膜

内膜肥厚は閉経前15mm以上
※閉経後は5mm以上

内膜分厚い！

大きな筋腫、腺筋症では
どうやらないようだ
内膜ポリープや、筋腫なら粘膜下
筋腫？

参考問題

30歳女性。未経妊。月経不順と過多月経を主訴に来院した。内診では子宮は正常大で、付属器には腫瘤を触知しない。経膈超音波検査では、子宮内膜の厚さは24mmで、卵巣の被膜下には多数の小嚢胞を認め、軽度に腫大している。

検査として適切なのはどれか。2つ選べ。

- a.腹腔鏡検査 b.子宮鏡検査 c.子宮卵管造影
d.子宮頸部細胞診 e.子宮内膜組織診

- ・ 体癌の否定はできず
 - ・ ポリープ 筋腫もありうる
 - ・ 超音波ではPCOSのようでもある
 - ・ でもやっぱり内膜が分厚い！
- 筋腫、ポリープ、体癌の鑑別のための検査が適切です

参考問題

30歳女性。未経妊。月経不順と過多月経を主訴に来院した。内診では子宮は正常大で、付属器には腫瘤を触知しない。経膈超音波検査では、子宮内膜の厚さは24mmで、卵巣の被膜下には多数の小嚢胞を認め、軽度に腫大している。

検査として適切なのはどれか。2つ選べ。

a.腹腔鏡検査

b.子宮鏡検査

c.子宮卵管造影

d.子宮頸部細胞診

e.子宮内膜組織診

- ・ 体癌の否定はできず
 - ・ ポリープ 筋腫もありうる
 - ・ 超音波ではPCOSのようでもある
 - ・ でもやっぱり内膜が分厚い！
- 筋腫、ポリープ、体癌の鑑別のための検査が適切です

問題

65歳女性が受診されました

主訴は**3か月前からの“不正”性器出血**です

<現病歴>

3ヶ月前から少量の性器出血が持続し、2週間前から増量している

<妊娠分娩歴>

3回経妊3回経産

<月経歴>

閉経52歳 初経は不明

<既往歴>

60歳から高血圧で降圧薬を内服している

問題

この時点での
鑑別を挙げてください

65歳女性が受診されました
主訴は**3か月前からの“不正”性器出血**です

<現病歴>

3ヶ月前から少量の性器出血が持続し、2週間前から増量している

<妊娠分娩歴>

3回経妊3回経産

<月経歴>

閉経52歳 初経は不明

<既往歴>

60歳から高血圧で降圧薬を内服している

問題

65歳女性が受診されました
主訴は**3か月前からの“不正”性器出血**です

＜現病歴＞

3ヶ月前から少量の性器出血が持続し、2週間前から増量している

＜妊娠分娩歴＞

3回経妊3回経産

＜月経歴＞

閉経52歳 初経は不明

＜既往歴＞

60歳から高血圧で降圧薬を内服している

- 65歳 →妊娠 月経関連出血は否定的
- 3経産・・・多産？ →頸癌？
- 閉経52歳・・・通常の閉経時期
- 既往歴 特記すべきことはない

不正性器出血の鑑別

1. ~~月経異常~~ ~~機能性出血(ホルモンバランスの乱れ)~~

2. ~~妊娠(切迫流産 絨毛性疾患 切迫早産)~~

3. 悪性腫瘍

1. 子宮頸癌 子宮体癌 膣癌 外陰癌

2. 卵巣境界悪性腫瘍(ホルモン産生) ; 顆粒膜細胞腫

4. 良性腫瘍

1. ~~子宮筋腫(特に粘膜下筋腫の筋腫分娩)~~

2. 頸管ポリープ 内膜ポリープ

5. 炎症 膣炎 萎縮性膣炎、クラミジア 淋菌など

6. 婦人科でない疾患

1. 痔核

2. 尿路系疾患

3. 出血性疾患

4. 抗凝固薬内服

- ・ 閉経後だとだいぶ鑑別が絞られる
- ・ 結構多いのは肛門 尿道からの出血を膣からの出血と勘違いする方々
- ・ 萎縮性膣炎も多い

問題①

65歳女性が受診されました
主訴は**3か月前からの“不正”性器出血**です

<現病歴>

3ヶ月前から少量の性器出血が持続し、2週間前から増量している

<妊娠分娩歴>

3回経妊3回経産

<月経歴>

閉経52歳 初経は不明

<既往歴>

60歳から高血圧で降圧薬を内服している

- ・ 65歳 →妊娠 月経関連出血は否定的
- ・ 3経産・・・多産？ →頸癌？
- ・ 閉経52歳・・・通常の閉経時期
- ・ 既往歴 特記すべきことはない

問題

不正性器出血の鑑別

1. 月経異常—機能性出血(ホルモンバランスの乱れ)
2. 妊娠(切迫流産—絨毛性疾患—切迫早産)
3. 悪性腫瘍
 1. 子宮頸癌 子宮体癌 陰癌 外陰癌
 2. 卵巣境界悪性腫瘍(ホルモン産生)；顆粒膜細胞腫
4. 良性腫瘍
 1. 子宮筋腫(特に粘膜下筋腫の筋腫分塊)
 2. 頸管ポリープ 内膜ポリープ
5. 炎症 陰炎 萎縮性陰炎、クラミジア 淋菌など
6. 婦人科でない疾患
 1. 痔核
 2. 尿路系疾患
 3. 出血性疾患
 4. 抗凝固薬内服

- ・ 閉経後だとだいぶ鑑別が絞られる
- ・ 結構多いのは肛門 尿道からの出血を膣からの出血と勘違いする方々
- ・ 萎縮性陰炎も多い

<現症>

身長157cm体重68kg体温36.4℃ 脈拍72/分、整 血圧148/88mmHg 表在リンパ節に腫大を認めない。

心音と呼吸音は正常である。腹部は平坦で、腫瘤を触れない。下肢に浮腫を認めない。

内診で膣分泌物は暗赤色、中等量。子宮膣部に異常を認めない。

双合診で子宮体部は鵝卵大に腫大してるが、付属器は触れない。直腸診で子宮傍組織は軟らかい。

<検査所見>

尿所見：蛋白(-)、糖(-)、潜血(-)。

血液所見：赤血球316万、Hb10.2g/dL、Ht31%、白血球6400、血小板28万。

血清生化学所見：総蛋白7.2g/dL、アルブミン4.8g/dL、尿素窒素18mg/dL、クレアチニン1.3mg/dL、AST18単位、ALT14単位、LDH248単位(基準176-353)。

免疫学所見：CEA3.7ng/mL(基準5以下)、CA19-9 33U/mL(基準37以下)、CA125 248U/mL(基準35以下)

子宮頸部細胞診NILM。胸部X線撮影で異常を認めない。経膣超音波所見を次に示す。

問題①

65歳女性が受診されました
主訴は3か月前からの“不正”性器出血です

<現病歴>

3ヶ月前から少量の性器出血が持続し、2週間前から増量している

<妊娠分娩歴>

3回経妊3回経産

<月経歴>

閉経52歳 初経は不明

<既往歴>

60歳から高血圧で降圧薬を内服している

- ・ 65歳 → 妊娠 月経不調
- ・ 3経産・・・多産？
- ・ 閉経52歳・・・通常の
- ・ 既往歴 特記すべきこ

この中の
大事な所見
を挙げてください

不正性器出血の鑑別

1. 月経異常—機能性出血(ホルモンバランスの乱れ)
2. 妊娠(切迫流産—絨毛性疾患—切迫早産)
3. 悪性腫瘍
 1. 子宮頸癌 子宮体癌 陰癌 外陰癌
 2. 卵巣境界悪性腫瘍(ホルモン産生) ; 顆粒膜細胞腫
4. 良性腫瘍
 1. 子宮筋腫(特に粘膜下筋腫の筋腫分塊)
 2. 頸管ポリープ 内膜ポリープ
5. 炎症 陰炎 萎縮性陰炎、クラミジア 淋菌など
6. 婦人科でない疾患
 1. 痔核
 2. 尿路系疾患
 3. 出血性疾患
 4. 抗凝固薬内服

- ・ 閉経後だとだいぶ鑑別が絞られる
- ・ 結構多いのは肛門 尿道からの出血を膣からの出血と勘違いする方々
- ・ 萎縮性陰炎も多い

<現症>

身長157cm体重68kg体温36.4℃ 脈拍72/分、整 血圧148/88mmHg 表在リンパ節に腫大を認めない。

心音と呼吸音は正常である。腹部は平坦で、腫瘤を触れない。下肢に浮腫を認めない。

内診で膣分泌物は暗赤色、中等量。子宮膣部に異常を認めない。

双合診で子宮体部は鵝卵大に腫大してるが、付属器は触れない。直腸診で子宮傍組織は軟らかい。

<検査所見>

尿所見：蛋白(-)、糖(-)、潜血(-)。

血液所見：赤血球316万、Hb10.2g/dL、Ht31%、白血球6400、血小板28万。

血清生化学所見：総蛋白7.2g/dL、アルブミン4.8g/dL、尿素窒素18mg/dL、クレアチニン1.3mg/dL、AST18単位、ALT14単位、LDH248単位(基準176-353)。

免疫学所見：CEA3.7ng/mL(基準5以下)、CA19-9 33U/mL(基準37以下)、CA125 248U/mL(基準35以下)

子宮頸部細胞診NILM。胸部X線撮影で異常を認めない。経膣超音波所見を次に示す。

問題①

65歳女性が受診されました
主訴は3か月前からの“不正”性器出血です

<現病歴>

3ヶ月前から少量の性器出血が持続し、2週間前から増量している

<妊娠分娩歴>

3回経妊3回経産

<月経歴>

閉経52歳 初経は不明

<既往歴>

60歳から高血圧で降圧薬を内服している

- ・ 65歳 →妊娠 月経関連出血は否定的
- ・ 3経産・・・多産？ →頸癌？
- ・ 閉経52歳・・・通常の閉経時期
- ・ 既往歴 特記すべきことはない

問題

不正性器出血の鑑別

1. 月経異常—機能的出血(ホルモンバランスの乱れ)
2. 妊娠(切迫流産—絨毛性疾患—切迫早産)
3. 悪性腫瘍
 1. 子宮頸癌 子宮体癌 陰癌 外陰癌
 2. 卵巣境界悪性腫瘍(ホルモン産生)；顆粒膜細胞腫
4. 良性腫瘍
 1. 子宮筋腫(特に粘膜下筋腫の筋腫分塊)
 2. 頸管ポリープ 内膜ポリープ
5. 炎症 陰炎 萎縮性陰炎、クラミジア 淋菌など
6. 婦人科でない疾患
 1. 痔核
 2. 尿路系疾患
 3. 出血性疾患
 4. 抗凝固薬内服

- ・ 閉経後だとだいぶ鑑別が絞られる
- ・ 結構多いのは肛門 尿道からの出血を膣からの出血と勘違いする方々
- ・ 萎縮性陰炎も多い

<現症>

身長157cm体重68kg体温36.4℃ 脈拍72/分、整 血圧148/88mmHg 表在リンパ節に腫大を認めない。

心音と呼吸音は正常である。腹部は平坦で、腫瘤を触れない。下肢に浮腫を認めない。

内診で膣分泌物は暗赤色、中等量。子宮膣部に異常を認めない。

双合診で子宮体部は鵝卵大に腫大してるが、付属器は触れない。直腸診で子宮傍組織は軟らかい。

<検査所見>

尿所見：蛋白(-)、糖(-)、潜血(-)。

血液所見：赤血球316万、Hb10.2g/dL、Ht31%、白血球6400、血小板28万。

血清生化学所見：総蛋白7.2g/dL、アルブミン4.8g/dL、尿素窒素18mg/dL、クレアチニン1.3mg/dL、AST18単位、ALT14単位、LDH248単位(基準176-353)。

免疫学所見：CEA3.7ng/mL(基準5以下)、CA19-9 33U/mL(基準37以下)、CA125 248U/mL(基準35以下)

子宮頸部細胞診NILM。胸部X線撮影で異常を認めない。経膣超音波所見を次に示す。

問題①

65歳女性が受診されました
主訴は3か月前からの“不正”性器出血です

<現病歴>

3ヶ月前から少量の性器出血が持続し、2週間前から増量している

<妊娠分娩歴>

3回経妊3回経産

<月経歴>

閉経52歳 初経は不明

<既往歴>

60歳から高血圧で降圧薬を内服している

- ・ 65歳 → 妊娠 月経関連出血は否定的
- ・ 3経産・・・多産？ → 頸癌？
- ・ 閉経52歳・・・通常の閉経時期
- ・ 既往歴 特記すべきことはない

問題

不正性器出血の鑑別

1. 月経異常—機能性出血(ホルモンバランスの乱れ)
2. 妊娠(切迫流産—絨毛性疾患—切迫早産)
3. 悪性腫瘍
 1. 子宮頸癌 子宮体癌 膣癌 外陰癌
 2. 卵巣境界悪性腫瘍(ホルモン産生)；顆粒膜細胞腫
4. 良性腫瘍
 1. 子宮筋腫(特に粘膜下筋腫の筋腫分塊)
 2. 頸管ポリープ 内膜ポリープ
5. 炎症 膣炎 萎縮性膣炎、クラミジア 淋菌など
6. 婦人科でない疾患
 1. 痔核
 2. 尿路系疾患
 3. 出血性疾患
 4. 抗凝固薬内服

- ・ 閉経後だとだいぶ鑑別が絞られる
- ・ 結構多いのは肛門 尿道からの出血を膣からの出血と勘違いする方々
- ・ 萎縮性膣炎も多い

<現症>

身長157cm体重68kg体温36.4℃ 脈拍72/分、整 血圧148/88mmHg

心音と呼吸音は正常である。腹部は平坦で、腫瘤を触れない。下肢に浮腫

内診で膣分泌物は暗赤色、中等量。子宮膣部に異常を認めない。

双合診で子宮体部は鵝卵大に腫大してるが、付属器は触れない。直腸診で

- ・ 出血あり結構多め 子宮膣部異常ない
- ・ 頸癌ぽくはない
- ・ 膣炎というにはやや出血多い
- ・ やっぱり膣内の出血のようである

<検査所見>

尿所見・蛋白(-) 糖(-) 潜血(-)

・ 頸癌ではなかろう

Ht31%、白血球

- ・ 閉経後でCA125異常値は大問題
- ・ ※月経ある場合は上昇する事あり

血清生化学検査：総蛋白7.2g/dL、アルブミン4.8g/dL、尿素窒素18mg/dL、クレアチニン1.3mg/dL、AST18単位、ALT14単位、LDH248単位(基準176-353)。

免疫学検査：CEA3.7ng/mL(基準5以下)、CA19-9 33U/mL(基準37以下)、CA125 248U/mL(基準35以下)

子宮頸部細胞診NILM。胸部X線撮影で異常を認めない。経膣超音波所見を次に示す。

不正性器出血の鑑別

1. ~~月経異常—機能性出血(ホルモンバランスの乱れ)~~
2. ~~妊娠(切迫流産—絨毛性疾患—切迫早産)~~
3. **悪性腫瘍**
 1. 子宮頸癌 **子宮体癌** 膣癌 外陰癌
 2. 卵巣境界悪性腫瘍(ホルモン産生) ; 顆粒膜細胞腫
4. ~~良性腫瘍~~
 1. ~~子宮筋腫(特に粘膜下筋腫の筋腫分娩)~~
 2. ~~頸管ポリープ 内膜ポリープ~~
5. ~~炎症—膣炎—萎縮性膣炎、クラミジア—淋菌など~~
6. ~~婦人科でない疾患~~
 1. ~~痔核~~
 2. ~~尿路系疾患~~
 3. ~~出血性疾患~~
 4. ~~抗凝固薬内服~~

・ 絞られましたね

經腔超音波所見



経膈超音波所見

子宮内膜の肥厚所見



問題

C22 診断に有用な検査はどれか。2つ選べ。

- a. プロゲステロン負荷テスト
- b. 子宮内膜組織診
- c. 子宮卵管造影
- d. コルポスコーピー
- e. ヒステロスコピー

C23 その後悪性所見が確認された。この疾患の拡がりの検索に必要性が最も低いのはどれか。

- a. 骨盤部MRI
- b. 腹部造影CT
- c. 骨盤血管造影
- d. 膀胱鏡検査
- e. 直腸鏡検査

C24 全身検索で遠隔転移を認めなかった。治療法として最も適切なのはどれか。

- a. 手術
- b. 抗癌化学療法
- c. 温熱療法
- d. 放射線治療
- e. ホルモン療法

子宮体癌と子宮頸癌

子宮頸癌

- ✓ 若年結婚
- ✓ 妊娠出産回数が多い
- ✓ HPV等性感染症
- ✓ 衛生状態悪く低所得層

子宮体癌

- ✓ 未婚、不妊、月経不順
- ✓ 初妊・初婚年齢が高い
- ✓ 妊娠出産回数が少ない
- ✓ エストロゲン内服歴
- ✓ 衛生状態よく高学歴

子宮体癌と子宮頸癌



子宮体癌

- ✓ 未婚、不妊、月経不順
- ✓ 初妊・初婚年齢が高い
- ✓ 妊娠出産回数が少ない
- ✓ エストロゲン内服歴
- ✓ 衛生状態よく高学歴

子宮体癌の症状 = 不正性器出血

初期から90%前後の症例にみられる

更年期・閉経後の不正性器出血が特徴的

若年者では無排卵、未産、多嚢胞性卵巣(PCO)など疫学が重要
その他

帯下感： 漿液性から血性

下腹部痛： Simpson徴候（子宮留膿症・留血腫）

進行癌では浸潤や遠隔転移による症状

子宮体癌の診断

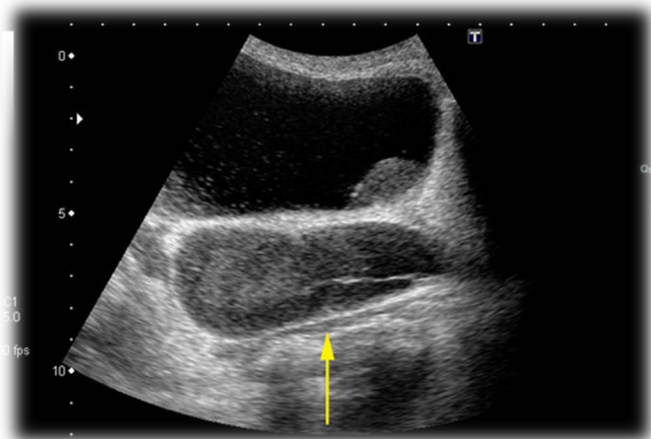
1. 視診、触診、内診：

出血の有無、出血部位の確認
子宮の大きさ硬度、周囲への浸潤の有無、
鼠径リンパ節転移の有無

2. 子宮内膜細胞診：癌の存在を証明

子宮頸部細胞診では体癌を50%見落とす

超音波検査：子宮内膜肥厚の有無（閉経後5mm以上）



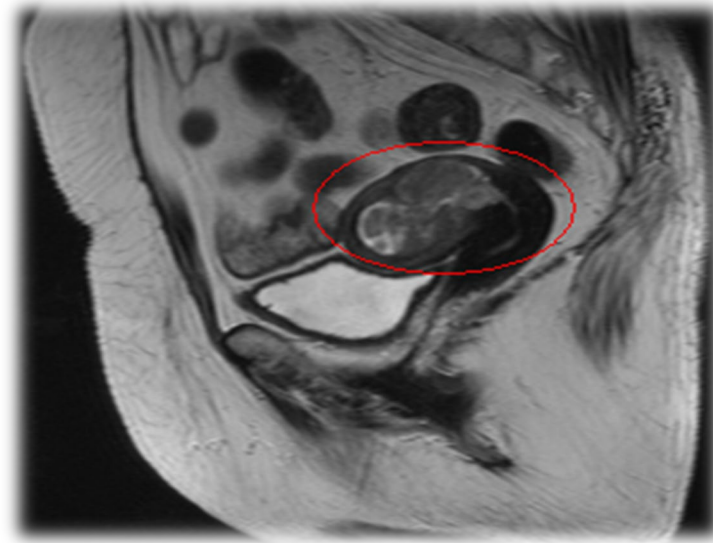
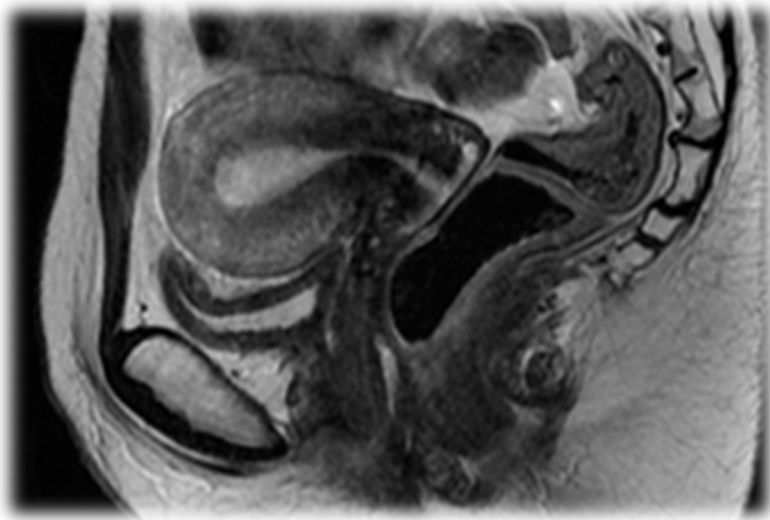
子宮体癌の診断

3. 子宮内膜の組織診：組織型を推定（病理診断で確定）

ヒステロスコープ：子宮内腔の観察

画像診断(CT,MRI,PET)：病巣の評価、浸潤や転移

腫瘍マーカー：CA 125、CA 19-9など



子宮体癌の治療-手術

子宮体癌の基本的治療方法
子宮および付属器摘出
+リンパ節郭清

術式は確定しているとはいえない
・単純～準広汎～広汎子宮全摘
・両側付属器切除
・骨盤内リンパ節郭清
・傍大動脈リンパ節郭清

術前に I A期と予測され、組織型が類内膜癌の
高分化または中分化型であれば腹腔鏡下手術（もしくはロボット）

問題

C22 診断に有用な検査はどれか。2つ選べ。

- a. プロゲステロン負荷テスト b. 子宮内膜組織診 c. 子宮卵管造影
d. コルポスコピー e. ヒステロスコピー

C23 その後悪性所見が確認された。この疾患の拡がりの検索に必要性が最も低いのはどれか。

- a. 骨盤部MRI b. 腹部造影CT c. 骨盤血管造影
d. 膀胱鏡検査 e. 直腸鏡検査

C24 全身検索で遠隔転移を認めなかった。治療法として最も適切なのはどれか。

- a. 手術 b. 抗癌化学療法 c. 温熱療法
d. 放射線治療 e. ホルモン療法

問題

C22 診断に有用な検査はどれか。2つ選べ。

- a. プロゲステロン負荷テスト b. 子宮内膜組織診 c. 子宮卵管造影
d. コルポスコピー e. ヒステロスコピー

C23 その後悪性所見が確認された。この疾患の拡がりの検索に必要性が最も低いのはどれか。

- a. 骨盤部MRI b. 腹部造影CT c. 骨盤血管造影
d. 膀胱鏡検査 e. 直腸鏡検査

C24 全身検索で遠隔転移を認めなかった。治療法として最も適切なのはどれか。

- a. 手術 b. 抗癌化学療法 c. 温熱療法
d. 放射線治療 e. ホルモン療法

問題

C22 診断に有用な検査はどれか。2つ選べ。

- a. プロゲステロン負荷テスト b. 子宮内膜組織診 c. 子宮卵管造影
d. コルポスコピー e. ヒステロスコピー

C23 その後悪性所見が確認された。この疾患の拡がりの検索に必要性が最も低いのはどれか。

- a. 骨盤部MRI b. 腹部造影CT c. 骨盤血管造影
d. 膀胱鏡検査 e. 直腸鏡検査

C24 全身検索で遠隔転移を認めなかった。治療法として最も適切なのはどれか。

- a. 手術 b. 抗癌化学療法 c. 温熱療法
d. 放射線治療 e. ホルモン療法

アンケート回答お願いします

- 出席の参考にします

医学科授業アンケート2026年 生殖
機能（婦人科）



質問などは下記連絡先へ

西川隆太郎（にしかわ りゅうたろう）

E-Mail: ryu0717@med.nagoya-cu.ac.jp

院内PHS: 4773(院内のみ)

医学科授業アンケート2026年 生殖
機能（婦人科）

